Cabinet de dermatologie Es-Senia

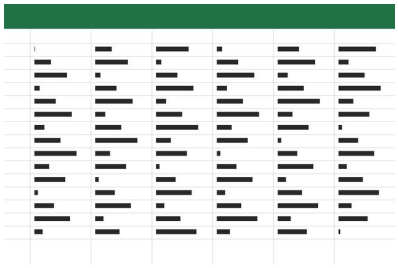
تقرير المساعدة على الفرز — آفة جلدية

dermIA الإصدار 2.0.0 · النموذج ham10000-m5-v2 الإصدار 2.0.0 (الملف: كامل)

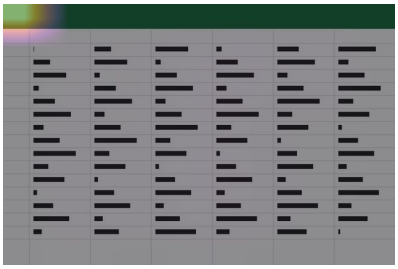
المريض	P-2026-0431	تاريخ التحليل	19:08 18/10/2026
العمر (بالسنوات)	46	طلب التحليل	Dr Karim Haddad
الجنس	أنثى	الموضع	اليد
الآفة المتابعة	رقم 1	عتبات القرار	الأصلية

إحالة إلى الطبيب

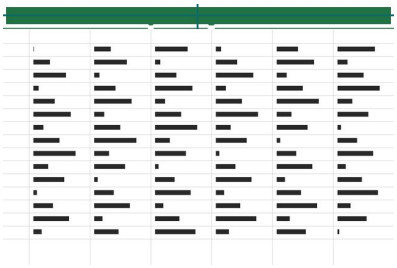
نتيجة غير مؤكدة: الذكاء الاصطناعي يمتنع عن الحكم
تبقى عدة تشخيصات محتملة عند مستوى الثقة المضمون. يجب أن يفحص الطبيب هذه الحالة.



الصورة المحللة



المناطق الأكثر تأثيرا (Grad-CAM، «وحمة ميلانينية»)



الحدود والمحاور المستخدمة في معايير ABCD

الاحتمالات المقدرة

التشخيص	الاحتمال	ضمن المجموعة المضمونة*
وحمة ميلانينية	74,1%	نعم
تقرن حميد	8,7%	
آفة وعائية	8,6%	نعم
ورم ميلانيني	3,5%	
ورم ليفي جلدي	2,9%	
سرطانة الخلايا القاعدية	1,5%	
تقرن سفعي / داء بوين	0,7%	

* المجموعة المطابقة (طريقة موندريان، ألفا = 0,10): تحتوي على التشخيص الصحيح باحتمال لا يقل عن 90% لكل فئة، بافتراض أن الحالات تشبه بيانات المعايرة. يتخذ قرار الورم الميلانيني إذا كان p(mel) ≥ 0,10 (نسبة التكلفة R = 10).
عتبات النموذج الأصلية، معايرة على مجموعة المعايرة من HAM10000.
تنبيه: صورة غير نمطية للتنظير الجلدي، حللت بطلب من المستخدم: يجب تفسير النتيجة بحذر شديد.

معايير ABCD الآلية (استرشادية)

المعيار	القياس	التفاصيل
A — عدم التناظر	0/2	محاور رئيسية غير متناظرة (الشكل أو الألوان)
B — الحواف	4/8	قطاعات ذات حافة حادة
C — الألوان	1/6	أزرق رمادي
D — القطر	15,0 مم	أكثر من 6 مم

تنبيه: تلامس الآفة حافة الصورة: المعايير A وB وD أقل موثوقية.
قياسات آلية استرشادية: على مجموعة الاختبار من HAM10000 لا يميز كل منها بين الورم الميلانيني والوحمة إلا بشكل محدود (AUC من 0,66 إلى 0,73). وهي لا تغني عن الفحص بالمنظار الجلدي.

المراجعة الطبية

لم يراجعها طبيب بعد.

توقيع الطبيب: _____

تنبيه. أعدت هذه الوثيقة بواسطة أداة للمساعدة على اتخاذ القرار، وهي لا تعد تشخيصا ولا تغني عن الفحص السريري ولا عن الفحص النسيجي. حالة النموذج: عرض توضيحي — استخدام غير تجاري — ليس جهازا طبيا. بيانات التدريب: HAM10000 (Tschandl et al., Sci Data 2018, doi:10.1038/sdata.2018.161) — الترخيص CC BY-NC 4.0 (غير تجاري).